

Điều Trị Tiểu Đường Type 2

Điều Trị Tiểu Đường Type 2

NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRỊ

Điều trị tiểu đường type 2 là quá trình lâu dài, kết hợp thay đổi lối sống và thuốc. Mục tiêu: kiểm soát đường huyết, ngăn biến chứng, duy trì chất lượng sống.

THUỐC UỐNG PHỔ BIẾN

Metformin (Glucophage):

- Thuốc đầu tay cho hầu hết bệnh nhân tiểu đường type 2
- Giảm sản xuất glucose từ gan, tăng nhạy cảm insulin
- Uống sau ăn để giảm tác dụng phụ (buồn nôn, tiêu chảy)
- Giá rẻ, an toàn, không gây hạ đường huyết khi dùng một mình
- Chống chỉ định: suy thận nặng (GFR < 30)

Nhóm SGLT-2 (Empagliflozin, Dapagliflozin):

- Thải đường qua nước tiểu
- Bảo vệ tim và thận (lợi ích ngoài đường huyết)
- Có thể gây nhiễm trùng đường tiết niệu

Nhóm GLP-1 (Semaglutide - Ozempic):

- Kích thích tiết insulin, ức chế glucagon
- Giảm cân tốt (phụ lợi ích lớn)
- Dạng tiêm tuần 1 lần hoặc uống ngày 1 lần

Sulfonylurea (Glibenclamide, Glimepiride):

- Kích thích tuyến tụy tiết insulin
- Rẻ, hiệu quả nhưng có thể gây hạ đường huyết
- Tăng cân nhẹ

INSULIN

Khi nào cần insulin?

- HbA1c > 10% và đường huyết rất cao
- Thuốc uống tối đa nhưng không kiểm soát được
- Suy thận, suy gan (không dùng được nhiều thuốc uống)
- Mang thai bị tiểu đường

Các loại insulin:

- Insulin nền (Glargine, Detemir): tiêm 1 lần/ngày, kiểm soát đường huyết đói
- Insulin bữa ăn (Regular, Aspart): tiêm trước ăn, kiểm soát đường huyết sau ăn
- Insulin trộn sẵn: tiện lợi, tiêm 2 lần/ngày

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Danh mục: Điều Trị & Thuốc

KHÔNG tự ý ngừng thuốc dù cảm thấy khoẻ - tiểu đường type 2 là bệnh mãn tính.

KHÔNG tự tăng/giảm liều thuốc mà không hỏi bác sĩ.

Báo ngay cho bác sĩ nếu: hạ đường huyết thường xuyên, đường huyết quá cao, tác dụng phụ lạ.

TÁI KHÁM ĐỊNH KỲ

3 tháng/lần: đường huyết, HbA1c, huyết áp, cân nặng

6 tháng/lần: mỡ máu, chức năng thận (creatinine, GFR)

12 tháng/lần: khám mắt, khám bàn chân